EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 87462
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-06-27 14:38:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ROSA AUDILIA MU►OZ AGURTO			RUN	: 8.750.352-6
F.Nac	: 17-10-1956	Edad	: 67 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: QUELTEHUES 0821 V. EL BOSQUE actualizado			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 977314621		
Fecha Ingreso	: 2024-06-24	Fecha Egreso	: 2024-06-27 14:38:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. D64.9-ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. LRA KDIGO II no Oligurica , multifactorial, en resolución
2. Hiperkalemia resuelta
3. ITU
- UC (+) Ecoli MS
4. ICC Fevi desconocida
5. TEP en DOAC (mayo 2024)
6. DM2 IR con amputación EEII bilateral
7. Hipotiroidismo
8. Hipertensión arterial.
9. Asma Bronquial

Procedimientos realizados UTI: Linea arterial radial izquierda (25/06/24)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E87.5-HIPERPOTASEMIA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. E11.5-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMP. CIRC.PERI (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. E03.9-HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
9. J45.9-ASMA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes conocidos y medicamentos descritos , ingresa a urgencias por cuadro de mialgias de 2 a 3 días de evolución asociado a compromiso del estado general. Febrícula asociada , escasos síntomas respiratorios. Evaluada en urgencias donde destaca LRA con creatinina 2.0 (basal 0.8) junto a hiperkalemia de 7.3 sin alteraciones electrocardiograficas en electrocardiograma y monitor. Destaca examen de orina inflamatorio junto a bacterias abundantes.
Se instauran medidas hipokaleamiantes en primer momento y luego de toma nuevo examen con nulo descenso de este. Se pide evaluación por UTI , se decide ingreso a unidad por AKI sumada a hiperkalemia. Paciente evoluciona con hemodinamia estable, sin requerimiento de DVA, ventilando espontaneo sin requerimiento de FiO2 adicional. Afebril, en tratamiento con ceftriaxona, se rescata UC (+) E coli sensible a Ceftriaxona. Funcion renal comprometida sumado a hiperkalemia, se inicia manejo de falla renal y trastorno HE con buena respuesta, examenes 27/06 Crea 1.1 ELP 138/3.8/117. Metabolicamente estable, sin embargo paciente poco cooperadora, se niega a alimentarse en ocasiones.

Actualmente en condiciones de alta, falla renal resuelta. Se decide HODOM para completar tratamiento ATB con ceftriaxona.

PLAN DE MANEJO:

HODOM --> Completar tratamiento antibiotico.
Control UC 08/07/24 en su Consultorio. Revisar resultado con medico en APS

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido. Prevención UPP
2. Regimen liviano diabético hiposódico. Asegurar Hidratación vía oral
3. Ceftriaxona 2 gr/día ev (5). Completar 7 dias
4. Omeprazol 20 mg 1 comprimido al dia vo
5. Apixaban 2.5 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
6. Carvedilol 6,25 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
7. Empaglifozina 10 mg 1 comprimido al dia vo
8. Metformina 850 mg 1 comprimido al dia vo
9. Elcal D 1 comprimido al dia vo
10. Levotiroxina 100 mcg 1 comprimido al día vo (en ayunas)
11. Ac. Fólico 5 mg 1 comprimido al día vo
12. Quetiapina 25 mg 1 comprimido por noche vo
13. Bromuro ipratropio 2 puff c/6hrs c/AC
14. Brexotide 2 puff c/12 hrs c/AC
15. Seguimiento por HODOM

EXÁMENES Y RESULTADOS

27/06/24: Crea 1.1, ELP 13/3.8/117 TTPK 61 INR 1.22 Glicemia 96 Uremia 53
26/06/24: Crea 1.3 PCR 22 ELP 137/4/119 TTPK 74
25/06/24: Crea 1.4 PCR 25 ELP 140/5.3/119 GB 14100 Hb 8.4 Hto 25.6% PQT 414000 TTPK 35

Control en: 15 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

DANIELA VASQUEZ BAHAMONDEZ
MEDICO TRATANTE
16516335-4

JEFE SERVICIO